<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</td><td colspan="3">INTUBASI</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen
400.7.3.4/1240/2026</td><td>No.Revisi
02</td><td>Halaman :
1/3</td></tr>
<tr><td>STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL</td><td>Tanggal terbit

15 Juni 2026</td><td colspan="2">Ditetapkan
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Loekmono Hadi
Wakil Direktur Pelayanan

dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M
Pembina Tk.I
NIP. 19820915 200903 1 004</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Intubasi adalah memasukkan pipa udara napas buatan ke dalam trachea melalui mulit atau hidung</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">1. Membebaskan jalan napas
2. Untuk pemberian napas mekanik (dengan ventilator)
3. Untuk memudahkan penghisapan sekret</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">Standar Alat :

a. Trolley emergency
b. Laringoscope
c. Peralatan section
d. Spuit 5 cc
e. Sarung tangan
f. Plester atau hipafix
g. Gunting verban
h. Batal /penyangga
i. Bag Mask valve
j. Ventilator kalau perlu
k. OPA (oro pharingeal Airway)
l. ETT (Endo thracheal Tube) sesuai ukuran
m. Jelly</td></tr>
</table>

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**INTUBASI**		
	No.Dokumen 400.7.3.4 /12401/ 2026	No.Revisi 02	Halaman : 2/3

n. Stetoskop

Standar Pasien :

a. Inform consent

b. Pasien posisi tidur terlentang

Prosedur:

1. Troley emergemcy di dorong mendekat ke sisi tempat tidur.
2. Pasang monitor EKG untuk memonitor gambaran EKG selama pemasangan ETT agar segera dapat mengatasi bila terjadi gangguan irama jantung
3. Cek alat alat yang di perlukan dan pilih ukuran ETT sesuai kebutuhan.
4. Beri jelly / pelumas pada ujung ETT sampai daerah cuff
5. Lakukan hiperventilasi dengan BMV minimal 30 detik
6. Letakkan bantal atau penyangga pada oksiput setinggi 10 cm dan kepala tetap ekstensi.
7. Bila perlu lakukan penghisapan lendir.
8. Buka mulut dengan croos finger dan tangan kiri memegang laringoscope
9. Masukkan blade laringoscope menelusuri mulut sebelah kanan , sisihkan lidah ke kiri ,masukkan blade sampai dasar lidah , perhatikan agar lidah / bibir tidak terjepit di antara blade dan gigi pasien
10. 10.Angkat laringoscope ke atas dan ke depan dengan kemiringan 30-45 derajat , jangan menggunakan gigi sebagai tumpuan
11. 11.Bila pita suara sudah terlihat lakukan sellick manuever masukkan ETT sambil memperhatikan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**INTUBASI**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/1240/2026	No.Revisi 02	Halaman : 3/3
	bagian proximal cuff ETT melewati pita suara antara 1-2 cm atau pada kedalaman ETT 19-23 cm 12. Waktu untuk intubasi tidak boleh lebih dari 30 detik . Lakukan ventilasi dengan menggunakan bagging dan lakukan auskultasi , pertama pada lambung kemudian ke paru kanan dan kiri sambil memperhatikan perkembangan dada 13. Bila terdengar suara gurgling pada lambung dan dada tidak mengembang paru lepaskan ETT dan lakukan hyperventilasi lagi selama 30 detik dan 02 100 % selanjutnya lakukan intubasi kembali 14. Bila di lambung tidak terdengar gurgling dan kedua paru mengembang serta suara paru kanan dan kiri sama berarti pemasangan ETT sudah benar. 15. Kembangkan balon cuff dengan menggunakan spuit 5 cc dengan volume secukupnya sampai tidak terdengar suara kebocoran udara di mulut saat ventilasi 16. Lakukan fiksasi ETT dengan plester agar tidak terdorong atau tercabut 17. Lakukan ventilasi terus dengan 02 100 % kemudian bila perlu sambungkan dengan ventilator		
UNIT TERKAIT	Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensive IGD		